



CANCERS DES VOIES BILIAIRES

PR BENDRID M.

MODULE DE GASTRO-ENTÉROLOGIE 4^{eme} année 2025

SERVICE DE CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE –

E.H. DIDOUCHE MOURAD -UC 3

I. Rappels anatomiques et physiologiques

Les voies biliaires drainent la bile produite par le foie vers le duodénum.

Elles comprennent :

- Voies intra-hépatiques : canaux biliaires segmentaires → canaux hépatiques droit et gauche.
- Voies extra-hépatiques : canal hépatique commun + canal cystique = cholédoque (qui se jette dans le duodénum au niveau de l'ampoule de Vater).
Fonction : transport de la bile (sels biliaires, bilirubine, cholestérol) essentielle à la digestion lipidique et à l'élimination de la bilirubine conjuguée.

II. Définition et classification

Les cancers des voies biliaires regroupent :

1. Cholangiocarcinomes intra-hépatiques
2. Cholangiocarcinomes péri-hilaires (tumeur de Klatskin)
3. Cholangiocarcinomes distaux (siège extrahépatique bas)
4. Cancer de la vésicule biliaire (entité à part, mais souvent associé)

Histologie :

→ Dans 90 % des cas, adénocarcinome développant à partir de l'épithélium biliaire.

III. Épidémiologie

- Rare mais en augmentation, surtout en Asie du Sud-Est.
- Incidence : 1 à 2 /100 000 habitants/an (plus fréquente après 60 ans).
- Légère prédominance masculine.

Les cholangiocarcinomes intra-hépatiques représentent 15% des cancers primitifs du foie, au deuxième rang après les carcinomes hépatocellulaires (Lepage 2011, Rumgay 2022). Cette proportion est plus importante chez les femmes, notamment en Europe du Nord (59%) et de l'Ouest (40%) (Rumgay 2022). Les cancers de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques

sont des cancers peu fréquents. Leur incidence estimée en 2018 dans le monde était de 2,1 chez l'homme et de 2,4 chez la femme pour 100 000 personnes-années.

IV. Facteurs de risque

- Cholangite sclérosante primitive (risque majeur)
- Lithiase biliaire intra-hépatique
- Kystes du cholédoque
- Infection chronique par *Clonorchis sinensis* ou *Opisthorchis viverrini*
- Exposition aux nitrosamines, thorotrast (ancien agent radiologique)
- Maladies inflammatoires chroniques du foie et des voies biliaires

V. Anatomopathologie

- Adénocarcinome bien ou moyennement différencié
- Croissance : infiltrante, périductale, ou nodulaire
- Propagation : locale (parenchyme hépatique), ganglionnaire, puis métastatique (foie, poumons, péritoine)

VI. Diagnostic clinique

1. Signes révélateurs

Selon le siège :

- Forme péri-hilaire ou distale → ictère cholestatique progressif, prurit, urines foncées, selles décolorées, altération de l'état général
- Forme intra-hépatique → masse hépatique, parfois découverte fortuite
- Douleur souvent discrète (distension capsulaire)
- Pas de fièvre (différencie d'une angiocholite)

2. Examen clinique

- Ictère franc
- Prurit, amaigrissement, parfois hépatomégalie dure
- Pas de fièvre ni de frissons

VII. Examens complémentaires

1. Biologie

- Cholestase : ↑ phosphatases alcalines, GGT, bilirubine conjuguée
- Cytolyse modérée
- Marqueurs tumoraux : CA 19-9, ACE (peu spécifiques)

2. Imagerie

- Échographie abdominale : dilatation des voies biliaires, siège de l'obstacle
- Scanner hépatique : masse, extension loco-régionale, envahissement

vasculaire

- IRM + cholangio-IRM : examen de référence pour la cartographie biliaire
- Echo-endoscopie ou CPRE (cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique) : diagnostic et éventuellement drainage

Examen	Indications
TDM TAP	- Examen de 1^{re} intention avant tout geste endobiliaire - Volumétrie hépatique avant hépatectomie majeure
IRM hépatique	- En l'absence de métastase extra-hépatique, avant tout geste endobiliaire <u>Cholangiocarcinomes intra-hépatiques</u> - Séquences de diffusion et injection de chélates de gadolinium hépatospécifiques si résection envisagée
Cholangio-IRM	<u>Cholangiocarcinomes péri-hilaires et distaux</u> - Avant tout geste endobiliaire
PBH	<u>Cholangiocarcinomes intra-hépatiques</u> - De la tumeur - Du foie non tumoral à distance, notamment si chirurgie envisagée ou suspicion d'hépatopathie chronique sous-jacente - IHC CK7, CK20, CDX2/SATB2, TTF1, GATA3 (femme) ; CRP en 2^e intention <u>Cholangiocarcinomes péri-hilaires</u> - Non recommandée en l'absence de métastase
CPRE	<u>Cholangiocarcinomes péri-hilaires et distaux</u> - Non recommandée en 1^{re} intention en l'absence d'indication de drainage biliaire associé - Si effectuée : associer brossage biliaire (avec cytologie en couche mince) et biopsies endobiliaires (technique du cytobloc idéalement) - Si prélèvements négatifs ou atypiques : - Relecture cytologique rapide par anatomopathologiste expert - Si diagnostic toujours incertain : 2^e CPRE en centre spécialisé avec brossage et biopsies et cholangioscopie
Echo-endoscopie	<u>Cholangiocarcinomes péri-hilaires et distaux</u> - Tumeur résécable/patient opérable ou projet de transplantation hépatique : - Ponction de la tumeur primitive : à discuter avec un chirurgien hépato-biliaire expert (risque théorique d'essaimage) - Ponction ganglionnaire systématique en cas d'adénopathie(s) - Tumeur non résécable, patient inopérable/inéligible à la transplantation hépatique : ponction de la tumeur primitive ou d'adénopathie(s) envisageable
Cholangioscopie	Non recommandée systématiquement en 1 ^{re} intention
Endoscopies digestives	<u>Cholangiocarcinomes intra-hépatiques</u> - Si doute diagnostique après la PBH avec métastase d'un adénocarcinome
TEP FDG	- Non recommandée systématiquement pour le bilan d'extension - Si doute diagnostique après la PBH avec métastase d'un adénocarcinome
IgG4	<u>Cholangiocarcinomes péri-hilaires et distaux</u> - Dosage sanguin si doute diagnostique ou en l'absence de preuve histologique - Immunomarquage IgG4 et IgG sur biopsies endobiliaires avec infiltrat lymphoplasmocytaire
Albumine, bilirubine...	Evaluation de la fonction hépatique recommandée (notamment cholangiocarcinomes intra-hépatiques)
Laparoscopie exploratrice	A discuter si résection envisagée (sans la retarder) notamment si risque élevé de non-résécabilité

CPRE : cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique. Ig : immunoglobuline. IHC : immunohistochimie. IRM : imagerie par résonance magnétique. PBH : ponction-biopsie hépatique. TDM TAP : tomodensitométrie multiphasique thoraco-abdomino-pelvienne. TEP FDG : tomographie par émission de positons au fluorodésoxyglucose.

VIII. Diagnostic différentiel

- Cancer du pancréas céphalique
- Lithiase enclavée du cholédoque
- Cholécystite chronique scléro-atrophique
- Cholangite sclérosante primitive non tumorale

IX. Traitement

1. Chirurgical (seul curatif)

- Résection complète R0 selon le siège :
- Intra-hépatique → hépatotomie ou hépatectomie partielle
- Péri-hilaire → hépatectomie + résection biliaire + reconstruction
- Distal → duodéno-pancréatectomie céphalique (Whipple)
- Curage ganglionnaire systématique
- Marges histologiques déterminantes pour la survie

2. Drainage biliaire préopératoire

→ CPRE ou drainage percutané, surtout si ictère important

3. Adjuvants

- Chimiothérapie (gemcitabine + cisplatine) pour formes avancées ou inopérables
- Radiothérapie palliative possible

X. Pronostic

- Mauvais dans l'ensemble.
- Survie à 5 ans :
- 25–40 % si résécable
- <10 % si non résécable
- Résection complète R0 = seul facteur de survie significatif.

XI. Prévention et dépistage

- Suivi régulier des patients à risque (cholangite sclérosante, kystes du cholédoque)
- Éviction des parasites biliaires dans les zones endémiques
- Dépistage échographique et biologique (CA 19-9) dans populations à risque élevé

XII. Points clés à retenir

- Le cancer biliaire est rare, souvent diagnostiqué tard.
- Le symptôme cardinal est l'ictère cholestatique indolore.
- Le diagnostic repose sur l'imagerie, la cholangio-IRM étant l'examen de choix.
- La chirurgie complète est le seul traitement curatif.

- Pronostic sombre, d'où l'intérêt du diagnostic précoce dans les groupes à risque.

I. VOIES BILIAIRES INTRA-HÉPATIQUES

Elles se trouvent à l'intérieur du foie et accompagnent les branches portales et artérielles dans les espaces portes.

Leur rôle est de drainer la bile produite par les hépatocytes vers le hile hépatique.

1. Organisation

- Les canalicules biliaires : fins conduits entre les hépatocytes, sans paroi propre.
- Ils convergent en canaux de Hering, puis en canalicules biliaires interlobulaires.
- Ceux-ci deviennent les canaux biliaires segmentaires, puis les canaux hépatiques droit et gauche.

2. Drainage segmentaire

Chaque segment hépatique (classification de Couinaud) possède son propre canal biliaire.

Les canaux hépatiques droit et gauche se réunissent au hilaire du foie pour former le canal hépatique commun.

3. Pathologie typique

- Cholangiocarcinome intra-hépatique
- Lithiase biliaire intra-hépatique (maladie de Caroli)
- Cholangite sclérosante primitive

II. VOIES BILIAIRES EXTRA-HÉPATIQUES

Elles commencent au hile du foie et se prolongent jusqu'à l'ampoule de Vater dans le duodénum.

1. Constitution

- Canal hépatique commun (résulte de la jonction des canaux hépatiques droit et gauche)
 - Canal cystique venant de la vésicule biliaire
- Leur union forme le canal cholédoque (ou canal biliaire principal).

2. Trajet du cholédoque

Le cholédoque traverse quatre portions :

1. Portion sus-duodénale : dans le pédicule hépatique
2. Portion rétroduodénale : derrière la première portion du duodénum
3. Portion pancréatique : traversant la tête du pancréas

4. Portion intramurale : dans la paroi du duodénum, s'ouvrant au niveau de l'ampoule de Vater, souvent commune avec le canal pancréatique principal (canal de Wirsung).

3. Fonction

Conduire la bile vers le duodénum.

La bile peut être stockée dans la vésicule biliaire via le canal cystique, puis libérée après un repas gras sous l'effet de la cholécystokinine (CCK).

4. Pathologie typique

- Lithiase du cholédoque
- Cholangiocarcinome péri-hilaire ou distal
- Angiocholite
- Tumeur de l'ampoule de Vater.

La frontière entre les voies intra- et extra-hépatiques se situe au hile hépatique. C'est une distinction chirurgicale majeure : c'est là que se joue la stratégie opératoire dans les tumeurs dites hilaires (Klatskin).

CANCER DE LA VESICULE BILIAIRE

I- Introduction

Le cancer de la vésicule qui représente de 80 à 95 % des tumeurs des voies biliaires. Son incidence est variable selon pays et les groupes ethniques. L'incidence annuelle du cancer de la vésicule est de 2 cas pour 100 000 habitants.

La grande majorité des cancers sont des adénocarcinomes (90 % des cas), le plus souvent bien différenciés de type nodulaire ou papillaire.

L'âge moyen de survenue est de 65 ans. Il existe une forte prédominance féminine pour le cancer de la vésicule (3 femmes pour 1 homme).

II- Facteurs de risques

La lithiase vésiculaire est le principal facteur de risque du cancer de la vésicule biliaire et 70 à 95 % des cancers surviennent sur une vésicule

Le risque de dégénérescence semble plus élevé en cas de calculs volumineux.

La vésicule porcelaine est une forme particulière de cholécystite chronique Elle est associée à un cancer vésiculaire dans 10 à 30 % des cas. L'adénome vésiculaire est un facteur de risque qui est corrélé à la taille de l'adénome.(>10mm). Dans 2/3 ds cas on retrouve l'obésité, le tabac, le manque d'exercice physique.

III CLINIQUE

- ❑ L'existence d'une douleur de la région de la vésicule biliaire devenant lancinante
- ❑ Une jaunisse (ictère)
- ❑ Un amaigrissement inexpliqué
- ❑ Une masse palpable de l'hypocondre droit

IV DIAGNOSTIC

- ❑ Une échographie qui peut montrer un épaissement de la paroi vésiculaire et vérifier l'absence d'un envahissement du foie, de métastases ou d'une extension péritonéale
- ❑ Le scanner permet de confirmer l'épaississement de la paroi vésiculaire et vérifier l'absence ou la présence d'adénopathies du pédicule hépatique.

V TRAITEMENT

A- LA CHIRURGIE

Le traitement curatif du cancer de la vésicule biliaire est chirurgical mais il n'est pas toujours possible.

Pour les cancers superficiels (T1), limités à la muqueuse, sans embole lymphatique ni péri-nerveux et sans atteinte des ganglions (N0), le chirurgien réalisera une cholécystectomie seule.

Pour les tumeurs au-delà de T1 avec atteinte de la musculature (notamment sur la paroi juxta-hépatique): cholécystectomie associée à une résection segmentaire du foie ou une hépatectomie droite élargie, avec résection large des orifices de trocars en cas de réintervention après cholécystectomie laparoscopique.

B- TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE

Pour les tumeurs pN1 ou R1 :

- Une chimiothérapie à base gemcitabine et de platine qui est le standard actuel en situation métastatique.
- Une chimiothérapie à base de 5FU et acide folinique, gemcitabine et oxaliplatine (GEMOX) est une option alternative.
- Une association avec une radiothérapie peut, aussi, être envisagée.

REFERENCES:

<https://www.snfge.org> › TNCD 2023

